الرؤى الاستراتيجية: أداء المستشفى

ملخص تحليلي للبيانات التشغيلية والمالية للفترة الحالية

إجمالي الإيرادات	إجمالي المرضى	متوسط مدة الإقامة	الحالات الخطرة
552K	218	6.74 أيام	35.3%

أبرز الملاحظات التحليلية (Key Insights)

1. تركّز الإيرادات في تخصصات محددة

أظهرت البيانات أن حالات **الكسور والإنفلونزا** هي المحرك الأساسي للإيرادات ولحجم المرضى داخل المستشفى، تليها حالات السكري. هذا يشير إلى ضغط كبير على أقسام الطوارئ والعظام والأمراض الباطنية مقارنة بالتخصصات الأخرى مثل الجلطات والصداع النصفي التي تسجل أقل معدلات دخول وإيراد.

2. الهيمنة الديموغرافية لكبار السن

الغالبية العظمى من المرضى يندرجون تحت الفئة العمرية **(أكثر من 50 عاماً)** بفارق ضخم عن باقي الفئات. هذا يفسر ارتفاع "متوسط مدة الإقامة" (6.74 يوم) وارتفاع نسبة "الحالات عالية الخطورة" (35.3%)، حيث أن هذه الشريحة العمرية غالباً ما تحتاج لرعاية طبية أطول وأكثر تعقيداً.

3. التقلبات الموسمية الحادة في تدفق المرضى

يوجد تذبذب واضح في أعداد المرضى عبر الشهور؛ حيث تشهد المستشفى **ذروة قصوى في شهر مايو**، يليها انخفاض حاد جداً في شهر أغسطس. يعود المعدل للارتفاع مرة أخرى مع بداية الخريف في سبتمبر وأكتوبر.

4. تنوع المحفظة التأمينية

الإيرادات موزعة بشكل صحي نسبياً بين أنواع التأمين (الخاص، الحكومي، والمرضى بدون تأمين)، مما يقلل من المخاطر المالية للمستشفى في حال تأخر مدفوعات جهة معينة، وإن كان الاعتماد يميل قليلاً لصالح التأمين الخاص.

التوصيات المقترحة (Recommendations)

- **إدارة الموارد الموسمية:** إعادة جدولة إجازات الطاقم الطبي والتمريض لتجنب شهر مايو (وقت الذروة)، وتكثيفها في شهر أغسطس (وقت الركود) لتقليل التكاليف التشغيلية المهدرة.
- **التركيز على رعاية المسنين:** نظراً لأن أغلب المرضى فوق 50 عاماً، يُنصح بالاستثمار في تحسين برامج الرعاية الممتدة (Geriatric Care) وتجهيز الغرف لتكون أكثر ملاءمة وراحة لكبار السن لرفع مستوى رضا المرضى.
- **دعم أقسام العظام والطوارئ:** تخصيص ميزانية أكبر لتطوير أجهزة الأشعة وأدوات التجبير نظراً لأن "الكسور" هي المصدر الأول